

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escala de Placer de Snaith-Hamilton (SHAPS)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Escala de Placer de Snaith-Hamilton
Sigla	SHAPS
Autores	Snaith, R. P., et al.
Año	1995
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Depresión y anhedonia
Población	Adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Fresán et al., 2001)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	Acceso al artículo no equivale a dominio público del instrumento.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Depresión y anhedonia. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	Unidimensional (capacidad hedónica).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos
Número de ítems	14 ítems (situaciones cotidianas placenteras).
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Likert de 4 puntos (Totalmente de acuerdo a Totalmente en desacuerdo).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	Unidimensional (capacidad hedónica).
Ítems	14 ítems (situaciones cotidianas placenteras).
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Likert de 4 puntos (Totalmente de acuerdo a Totalmente en desacuerdo).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Existen dos métodos. Dicótomo original: "Totalmente de acuerdo/De acuerdo" = 0, "En desacuerdo/Totalmente en desacuerdo" = 1. (Rango 0-14). Método ordinal continuo (1 a 4, rango 14-56).

Regla de corrección	Existen dos métodos. Dicótomo original: "Totalmente de acuerdo/De acuerdo" = 0, "En desacuerdo/Totalmente en desacuerdo" = 1. (Rango 0-14). Método ordinal continuo (1 a 4, rango 14-56).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Puntuación dicotómica > 2 indica presencia clínica de anhedonia.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Mide específicamente *anhedonia* (incapacidad para experimentar placer), eliminando sesgos culturales y de clase social. Alta validez discriminante.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Mide específicamente *anhedonia* (incapacidad para experimentar placer), eliminando sesgos culturales y de clase social. Alta validez discriminante.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (Fresán et al., 2001)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 3 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Depresión y anhedonia en Adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Snaith, R. P., et al.; 1995.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Fresán et al., 2001)
- Trazabilidad local: 2 archivo(s) técnicamente legible(s) y 1 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Depresión y anhedonia
Población	Adultos
Estructura	Catálogo: 14 ítems (situaciones cotidianas placenteras).; Unidimensional (capacidad hedónica).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Existen dos métodos. Dicótomo original: "Totalmente de acuerdo/De acuerdo" = 0, "En desacuerdo/Totalmente en desacuerdo" = 1. (Rango 0-14). Método ordinal continuo (1 a 4, rango 14-56).
Interpretación	Puntuación dicotómica > 2 indica presencia clínica de anhedonia.
Estado de fuentes	Locales válidos: 2; web PDF: 1; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Snaith, R. P., et al. (1995). Escala de Placer de Snaith-Hamilton.

Fuente de referencia del catálogo: Disponible en artículos académicos.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7551619/>

<https://actaspsiquiatria.es/index.php/actas/article/view/815>

<https://actaspsiquiatria.es/index.php/actas/article/download/815/1292/1309>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	SHAPS española, 14 ítems. Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 179fbb0a1ce82ebd2cd00e0e8f813e66d8a3e007 917 645a08b7eb82e59ed17c2.
2. Población e informante	Ficha previa: Adultos. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	Autoinforme.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	SHAPS española, 14 ítems.
6. Periodo temporal	No se confirma periodo explícito en el activo.
7. Escala/formato de respuesta	Cuatro opciones de acuerdo/desacuerdo; puntuación dicotómica según clave.
8. Algoritmo de puntuación	Recodificar cada ítem 0 (De acuerdo/Totalmente de acuerdo) o 1 (En desacuerdo/Totalmente en desacuerdo) conforme a la clave; suma 0–14. El corte depende de la validación seleccionada.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	Validación mexicana en pacientes con depresión: $\alpha=.77$; evidencia de validez/fiabilidad en la fuente citada.
11. Baremos, cortes e interpretación	Puntuación dicotómica > 2 indica presencia clínica de anhedonia. Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	Estado conservador: Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir. No redistribuir/modificar hasta documentar titular y permiso de la versión exacta.
13. Referencias y fuentes verificadas	Fresán et al., validación mexicana, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23884614/ ; texto completo: https://actaspsiquiatria.es/index.php/actas/article/download/815/1292/1309 .
14. Decisión de QA	PARCIALMENTE COTEJADO: estructura visible contrastada con Protocolo.pdf. Los campos marcados NO VERIFICADO siguen bloqueando una declaración de completitud clínica.